



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : نجلاء عبدالعظيم عبدالوهاب عطيه

العنوان : -----

الحى / المدينة : اوسيم

المحافظة : الجيزه

تاريخ تسجيل الإستماره : 06-10-2026

رقم البطاقة : 28601012117204 رقم التليفون : 01147446788

العمر (تاريخ الميلاد) : 01-01-1986 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان	الوظيفة: -----	التوقيع: -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / ----- / أ.د. / ----- / د. / ----- / د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نجلاء عبدالمعظم عبدالوهاب عطيه National ID: 28601012117204	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الى Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية

نجلاء
عبدالعظيم عبدالوهاب عطيه
 قرية اوسيم
 مركز اوسيم - الجيزة

١٩٨٦/٠٧/٠١ ٢٨٦٠١٠١٢١١٧٢٠٤
 KV7641254


 ٢٠٢٤/١١ ٢٨٦٠١٠١٢١١٧٢٠٤
 ربة منزل

أنثى
 مسلمة
 متزوجة
 محمود صلاح الدين محمد محمد حسين
 البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/١١/١٠





Patient Name : الأستاذة / نجلاء عبدالعظيم عبدالعظيم عبدالوهاب
Patient No. : 28601012117204
Path No. : 2688/23
Sex : Female
Age : 37 Y
Referring Doc :
Request No. : 13008899
Request Date : 16/08/2023
Verification Date : 28/08/2023
Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data:
Bilateral breast lesions

Nature of specimen:
Tru cut biopsies, collected at 15/8/2023 , 3:40 pm

Gross examination:

1) Right breast:

Four greyish white tissue cores up to 1.5 cm , totally submitted.

2) Left breast:

Four greyish white tissue cores up to 1 cm , totally submitted.

Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

1) Right breast:

* Histological type: Invasive duct carcinoma .

* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II

* DCIS: Could not be detected within the limits of biopsy recieved.

* Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy recieved.

* IPT:

ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8)

PR: Weak nuclear reaction in 15% of tumor cells (Allred score 4/8)

Her-2: Weak membrane reaction in 10% of tumor cells (score 1+)

Ki 67: 10 % nuclear reaction in tumor cells

2) Left breast:

-Examination of the stained slide reveals increase in glandular elements plus stromal

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 05/09/2023 09:28:26

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مبنى القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mizr El Qadima- Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / نجلاء عبدالعظيم عبدالوهاب :	Request No. : 13008899
Patient No. : 28601012117204	Request Date : 16/08/2023
Path No. : 2688/23	Verification Date : 28/08/2023
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Age : 37 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

fibrosis and sclerosis that distorts and compresses glands. Centrally is more cellular with distorted and compressed ductules; peripherally has more open or dilated ductules. Myoepithelial cells are indistinct in the examined section.

IPT:
P63 and Calponin: Diffuse positive both inside the ducts and in lining myoepithelial cells.

Diagnosis:

1) Right breast lesion, tru cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II .

IPT:

ER: Positive (score 8/8).

PR: Positive (score 4/8).

HER-2: (Score 1+).

Ki67: Positive in 10% of tumor cells.

2) Left breast lesion, tru cut biopsy:
- Benign complex sclerosing lesion.

Prof. Gamal Abdelatty

Dr. Menan Hossam

Dr. Menna Nabil

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 05/09/2023 09:28:26

Page 2 of 2

Printing By : Ali mostafa



Patient Name: Naglaa Abd Al Azeem Abd Al Wahab Attaya	Date : 23/11/2024
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 39 Year(s)
Medical ID: 3372/2023	Pat. ID: 41693

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

COMPARED with last study dated 24/1/2024

➤ **Findings: reported case of RIGHT BCS**

- Right breast operative bed shows focal area of parenchymal distortion, with increased skin thickness. With no evidence of recurrence.
 - **Still noted**
 - Bilateral prominent axillary level I and II lymph nodes and the largest seen in right measuring 12x6 mm.
 - Middle lung lobe and left LLL atelectatic bands.
 - No sizable pulmonary nodules or masses
 - No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
 - No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
 - No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
 - Thymic hyperplasia is seen
 - Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
 - Lytic manubrium sternum lesion for bone scan correlation.
- 1. Abdomen and pelvis:**
- The liver is enlarged in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions (on non-contrast) or contour irregularities.
 - No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.



Patient Name: Naglaa Abd Al Azeem Abd Al Wahab Atteya	Date : 23/11/2024
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 39 Year(s)
Medical ID: 3372/2023	Pat. ID: 41693

- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Still noted small lucent area at manubrium

OPINION:

- Status follow up running a rather stationary course since the last study

Prof. Menna Tallah Hanafy, M.D.